



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : الهام سيد محمود محمد
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : سته اكتوبر
رقم البطاقة : 27602162300301 رقم التليفون : 01155686749
العنوان : يبي
العمر (تاريخ الميلاد) : 16-02-1976 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6977] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: الهام سيد محمود محمد National ID: 27602162300301	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الى Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

النهام
سيد محمود محمد
عماره ١٧ ب. مجاوره ٦ - حي ١٠
٦ أكتوبر أول - الجيزة

١٩٧٦/٠١/٢٢ ٢٧٦.٢١٦٢٣.٠٠٣.٠١

I24031681

٢٠٢١/٠٨ ٢٧٦.٢١٦٢٣.٠٠٣.٠١

حاصله على دبلوم في صناعي
متروية
مستلثة
أنثى عيسى احمد
ناصر سارية حتى
البطاقة

٢٠٢١/٠٨/٠٦

Patient Name : الأمل / الأمل / الأمل
Patient No. : 27602162300301
Path No. : 2266/24
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001177
Request Date : 07/07/2024
Verification Date : 16/07/2024
Financial Category : أورام داء الملحم - ميثرو
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast swelling post left mastectomy

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 6/7/2024.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 0.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

Histological type: Invasive duct carcinoma.
Grade (differentiation) nuclear pleomorphism (mitosis): (3+2+1) Grade II.
Ductal carcinoma in situ: Negative.
Perineural invasion: Negative.
Angioinvasion: Negative.
Microcalcifications: Negative

Remarks:
Left breast swelling post left mastectomy, Tru-cut biopsy.
Invasive duct carcinoma, Grade II.
Further IHC (ER, PR, Her2, Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Esraa Magdy.

Verified by
DR. Menna Nabil

Printing Date : 29/07/2024 08:38:17

Page 1 of 1

Printing By : marwa mohamed youss



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A- Patient ID:

1- Name: **لهم عبد المجيد**

Sex:

3- Medical number:

Female

83220344

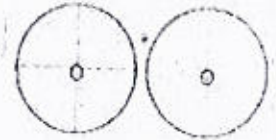
Old Med:

Old Age:

1015-2020

-ID number: 2780216230030.

Patient Age: 48 Y



Family history

Family History

Phone

Phone

011125307622

BMI

BMI

REASON OF MDT

REASON OF MDT

marital status

Marital Status

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Co morbidity

Co Morbidity

Menopausal status

Menopausal Status

Initial STAGE

Initial STAGE

05/05/2024

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup:

BX IDC	ER 8/8	PR 8/8	Her 2 Neu 1	SISH	Ki67 13
BX COMMENT	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	Ki67 COMMENT

T	N	M 1 lung skin
---	---	------------------

Sonomammography

PATIENT HISTORY

LT CBS & received 3 AC

6/2024 local recurrence

ct cap: PD locally + lung mets

biopsy local recurrence : IDC GII, ER8/8, PR 8/8 HER2:1+ Ki10%

pt reports amenorrhea since 2020

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for AI, hormonal profile

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	PATHOLOGY
Psychiatric	Nutrition

Pathology Report

Name: الهام محمد محمود

Age: 44 years.

Clinical data: Left breast mass.

Specimen type: Excision biopsy, Slide revision.

Date: 1/3/2020

Lab. Number: SR-32

Hospital Number: /2019

Gross Description:

1 H&E slide and 2 immunostained slides for revision.

Microscopic Examination:

Microscopic examination of the slides received revealed solid group of malignant cells with moderate pleomorphism and high nucleocytoplasmic ratio infiltrating fat. DCIS 5%. No lymphovascular emboli or perineural invasion.

Diagnosis:

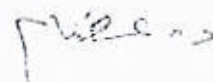
Left breast mass, excision biopsy, slide revision;

- " Invasive duct carcinoma, (IDC).
- " DCIS 5%.
- " No lymphovascular emboli.
- " No perineural invasion.
- " ER; 8/8.
- " PR; 8/8.
- " Her2 negative, score 1+.
- " Ki67; 40% of tumor cell.

Prof. Dr. Gamal A. Aty



Prof. Dr. Essam Ayad



Patient Name : الأستاذة / انعام سيد محمود محمد
Patient No. : 27602162300301
Path No. : 2266/24
Sex : Female
Age : 48 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13001177
Request Date : 07/07/2024
Verification Date : 28/07/2024
Financial Category : اورام دار السلام - ميثاره
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Initial Data:

Left breast swelling post left mastectomy.

Structure of Specimen:

True cut biopsy collected at 6/7/2024.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

PT (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
Her2: Weak incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+).
Ki67: 10 % nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left breast swelling post left mastectomy True-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.

ER: Positive(score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
Her2:(Score 1+).
Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 29/07/2024 08:30:23

Page 1 of 2

Printed By : .marwa mohamed yousse



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصريةالجمهورية
مصر

09/20/2026

MDT FORM

Name:	Al Ham El-Sayed Mahmoud *	MRN:	2598
Age:	51 Y	ID:	27602162300301
Menopausal Sta	post	Phone:*	01125307622
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	+ve (cousin)
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	no	surgical	
Surgical History:*	lt BCS	ECOG Performance Status	0 00 10 20 30 4

Clinical Data:

BX:		R		L			
ER:		PR:		HER2:		KI67:	

History:

50 Y/O F, H/O Lt BC, s/p BCS 2019, path pT1N1. Received AC x3 cycles, then Lostt FU.

06/2024: Developed Local recurrence

CT showed Lt breast lesion + prominent IM LNs (~9x4 mm) + Lt axillary LNs + prominent subcm cervical LNs + multiple subcm pulmonary nodules, largest 4 mm, considered indeterminate, not metastatic.

Started HT with Arimidex since 9/ 2024.

CT 07/2026: * Persistent Lt breast lesion.

* No pulmonary nodules/masses.

* No radiological evidence of other distant disease.

SM : R

surgical evaluation for LT MRM : operable

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

Pathological Staging:

Sonomammography:

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

after revision of imaging not metastatic for LT MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. محمد كركلي	د. محمد تاراي		

I/O
InputReadError
ReadImage
441

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

الهام
سيد محمود محمد
عماره ١٧ ب. مجاوره ٦ - حي ١٠
٦ أكتوبر اول - الجيزة

١٩٧٦/٠٧/١٦ ٢٧٦.٠٢١٦٢٣.٠٠٣.٠١
I24031681

I/O
InputReader
Error
ReadImage
441

PCL XL Error
Subsystem:
Error:
Operator:
Position:

Patient's Name: Ilham Sid Mahmoud
Date: 2026-07-11
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,

ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:

Known case of CA breast. Compared to the previous study dated 20/1/2026, the current study showed:

I- CHEST:

- No appreciable time interval changes regarding the previously seen left breast lesion, measuring 51 x 31 mm as well as the accompanying skin thickening.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Still noted multiple gall bladder stones.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulæ or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Few bilateral internal iliac subcentimetric lymph nodes.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Stationary course since last study.

Dr.sherif Wagdy